



Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé

N° de déclaration d'activité 93.83.04918.83 *Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat*

FINESS EJ : 83 000 904 9 - SIRET : 130 016 561 000 24 - Code APE 8412Z - DATADOCK : 0014425 DPC : 1073

Siège administratif : 32 avenue Becquerel – 83130 LA GARDE



BEYER Sébastien

Analyse de pratiques professionnelles

Comprendre la transmission et les interruptions de tâche

Stage n°1 SUC

MEM Promotion 2025-2028

En école de manipulateur en électroradiologie médicale, au semestre 1, je réalise mon premier stage en soins de chirurgie orthopédique dans un hôpital public de la région PACA, du 20 octobre au 7 novembre 2025. Cette immersion m'a permis d'observer le fonctionnement quotidien d'une équipe pluridisciplinaire composée de 1 médecins, 6 infirmières, 8 aides-soignantes, 3,5 agents de service hospitalier (7 mais qui font 2 services), et 1 kinésithérapeute intervenant en transversal.

J'ai rapidement identifié la répartition des tâches au sein de l'équipe.

Les aides-soignantes assurent le bien-être du patient au quotidien : installation dans le lit, aide aux repas, à la toilette, à la selle, accompagnement selon le degré de dépendance. Elles constituent également une première ligne de vigilance, repérant les situations problématiques comme une perfusion qui ne coule plus ou qui a été arrachée, avant d'alerter l'infirmière.

Les ASH, quant à eux, prennent en charge la désinfection des chambres et l'entretien des locaux.

L'infirmière coordonne l'ensemble des soins : elle gère les entrées de patients, met à jour les dossiers en respectant l'identitovigilance, rédige les cibles de soins, administre les médicaments, évalue la douleur, surveille l'état des cathéters et prend les constantes. C'est elle qui assure la continuité des soins par le biais des transmissions écrites et orales. Lors de ces transmissions, seules les infirmières en poste et celles prenant la relève échangent activement, sauf en cas de question directe adressée à une aide-soignante.

Dès les premiers jours, j'ai participé aux transmissions entre équipes. Ces moments structurants du service rassemblent habituellement 2 infirmières diplômées d'État titulaires, 2 étudiantes IDE, 2-3 aides-soignantes, 1 élève aide-soignante et 2 ASH. Les transmissions sont banalisées sur un créneau de 30 minutes, entre 13h30 et 14h, avec un écriteau bien visible sur la porte du bureau indiquant « Ne pas déranger - Transmission en cours ».

Ma difficulté principale est apparue dès les premiers jours : comprendre l'intégralité de ce qui se disait pendant les transmissions. Ce moment crucial ne permet pas de poser des questions, hormis celles qui contribuent directement à la transmission.

La situation s'est considérablement complexifiée lors de la relève du 28 octobre 2025, à 12h32 :

Ce jour-là, j'ai vécu une transmission particulièrement chaotique. J'ai comptabilisé 24 appels téléphoniques internes d'importance variable : demandes répétées de places disponibles dans le service, familles appelant directement pour obtenir des informations, autres services appelant pour demander des données, et tout ce que je ne sais pas. Malgré l'écriteau, plusieurs personnes sont entrées dans le bureau ou ont cogné à la porte : brancardiers, familles de patients, personnel d'autres services. À cela s'ajoutaient les alarmes patientes incessantes, heureusement souvent prises en charge par une aide-soignante.

La transmission initialement prévue pour 30 minutes a duré 1h10. J'ai eu l'impression de perdre le fil, de mélanger potentiellement certains cas, de ne pas avoir capté toutes les informations essentielles. Les acronymes que je ne maîtrisais pas étaient particulièrement nombreux ce jour-là : abréviations de médicaments, de pathologies, de situations cliniques. Le vocabulaire médical précis, même sans acronyme, restait difficile à saisir pour moi qui débute ma formation : noms de pathologies spécifiques, molécules, matériel médical ou marque spécifique.

De plus, j'ai eu du mal à distinguer ce qui relevait d'une prescription médicale ferme, d'une hypothèse diagnostique ou d'une alerte à transmettre au médecin (absent à ce moment). Cette confusion a nécessité des reformulations à posteriori. Enfin, quelques digressions sont venues s'intercaler, notamment sur la future réorganisation de service.

Cette expérience m'a amené à me poser plusieurs questions interconnectées :

Comment, lors d'une relève, puis-je identifier mes priorités en tant qu'étudiant et organiser efficacement ma journée ? Comment distinguer ce qui relève des actions à mener dans mon périmètre de compétence, des informations de suivi général ? Comment se structure concrètement une bonne transmission ? Quels sont les risques liés aux interruptions incessantes et comment les éviter ou les gérer ?

En analysant cette situation avec du recul, j'ai identifié plusieurs manquements dans ma préparation au stage.

Tout d'abord une préparation insuffisante. Le constat est simple : je ne m'étais clairement pas préparé à la dimension linguistique et organisationnelle du métier. J'avais naïvement pensé que commencer à apprendre les préfixes, suffixes et radicaux de l'UE 2.5 me donnerait une base solide. En réalité, le jargon professionnel va bien au-delà de ces bases théoriques.

Je m'étais concentré exclusivement sur les aspects techniques de la pratique : pose de cathéter (UE 4.1), hygiène (UE 3.10), besoins de la personne âgée (UE 3.11). Je n'avais pas du tout anticipé cet aspect communicationnel technique et organisationnel du métier d'infirmier, pourtant fondamental.

En outre j'avais une **représentation erronée de ce qu'était une transmission**. Je croyais que la transmission suffisait à savoir quoi faire dans la journée. Or, de nombreux autres supports viennent compléter cette information : dossier patient informatisé, prescriptions écrites, protocoles de service, plannings de soins. Je n'avais pas envisagé la multiplicité des sources d'information. Ce n'est pas un emploi du temps.

De plus je n'avais absolument pas anticipé les **interruptions incessantes**, ni réfléchi à des stratégies pour y faire face tout en restant concentré sur l'essentiel. Cette réalité du terrain m'a complètement dépassé.

Enfin en **Ressenti personnel** je me suis senti incompetent, réduit à un rôle de simple exécutant sans réelle compréhension de ce qui se jouait. Ce sentiment d'être submergé était d'autant plus frustrant que je savais que ces informations étaient essentielles pour la sécurité des patients.

Un manque de recherche préalable de ma part est indéniable, ainsi qu'un manque de connaissances logique à ce stade de ma formation.

Suite à cette expérience, j'ai effectué les recherches que j'aurais dû mener en amont du stage.

Tout d'abord le **Cadre réglementaire**, en effet, les transmissions sont encadrées par le Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013. Elles constituent une obligation légale et répondent à des besoins précis : continuité des soins, sécurité du patient, rééducation, expertise médicale.

Puis l'**importance de la communication structurée**, selon un rapport national Suisse, « l'un des facteurs les plus importants ayant un impact sur la sécurité des patients et ayant des risques d'induire des événements indésirables est une communication perturbée ou déficiente entre professionnels, mais aussi entre patients et soignants »

« La qualité de la communication dépend de plusieurs éléments : la qualité des données recueillies lors de l'évaluation clinique, le moment approprié pour effectuer cette évaluation, et surtout l'organisation structurée des informations à transmettre. Cette organisation requiert l'utilisation d'une méthode systématique permettant d'organiser les idées de manière claire »

La méthode SBAR ou SAED, j'ai découvert que la méthode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) constitue désormais un standard en matière de transmission. Cette méthode a été développée entre 1995 et 2003 aux États-Unis, spécifiquement pour le secteur médical, en collaboration avec des chercheurs en sécurité aérienne. Elle fait suite à des résultats très négatifs constatés dans l'analyse des dysfonctionnements liés aux transmissions. Depuis, elle semble utilisée dans la plupart des établissements de santé.

Concernant **les risques associés aux interruptions de tâche**, ils sont largement documentés par les autorités sanitaires nationales et internationales. La Haute Autorité de Santé rapporte qu'une infirmière est interrompue en moyenne 6,7 fois par heure, chaque interruption étant associée à une augmentation du risque d'environ 13% d'erreurs médicamenteuses (administration du mauvais médicament, omission d'enregistrement dans le dossier patient).

L'étude de référence de Westbrook et al. (2010), menée dans deux grands hôpitaux universitaires de Sydney, démontre des résultats particulièrement significatifs. Cette recherche observationnelle a analysé 4271 administrations de médicaments réalisées par 98 infirmières auprès de 720 patients. Les résultats montrent qu'à chaque interruption, les risques d'échec de procédure augmentent de 12,1% et les erreurs cliniques de 12,7%. Plus préoccupant encore, 53,1% des administrations de médicaments ont été interrompues au moins une fois. Sans interruption, le taux d'erreur clinique était déjà de 25,3%, mais il atteignait 38,9% avec trois interruptions.

Une étude de Bloomr-impulse apporte une analyse globale tout secteur : « il faut en moyenne 2min30 pour retrouver l'état de concentration avant l'interruption, 41% des tâches interrompues ne seraient pas reprises, selon le spécialiste de l'attention Cyril Couffe, les interruptions font perdre 28% de productivité.

Au niveau international, l'Organisation Mondiale de la Santé estime à 42 milliards de dollars américains le coût annuel des erreurs médicamenteuses dans le monde, ce qui représente près de 1% de l'ensemble des dépenses de santé au niveau mondial. L'OMS a lancé en mars 2017 le « Défi mondial pour la sécurité des patients - Les médicaments sans les méfaits » visant à réduire de 50% les effets graves évitables des erreurs de médication dans tous les pays au cours des 5 années suivantes.

Une étude menée en 2013 au CHU d'Angers identifie les interruptions de tâche comme la première cause d'événements indésirables graves (20%), devant l'absence de procédure formalisée et le défaut de contrôle. Sur 495 interruptions observées lors de la préparation et de l'administration des médicaments, seules 5% ont été considérées comme justifiées.

Outre la perte d'information, de qualité, les interruptions ont également un impact sur la santé des professionnels, selon l'étude de Bloomr les interruptions de tâche entraînent une « **surcharge cognitive**, fatigue mentale, frustration, sentiment de ne pas avancer et donc découragement...l'addition du zapping est salée, aussi bien pour le bien-être de chacun que pour la performance réelle au niveau collectif : le sujet n'est pas qu'individuel mais aussi systémique, voire sociétal. »

L'INRS fait le même constat : « *L'interruption de l'activité est un facteur de surcharge mentale et psychique largement reconnu.* » ; « *Les interruptions dans les activités deviennent beaucoup plus fréquentes. Il en résulte une charge mentale croissante qui favorise le développement du stress...* »

Ces interruptions génèrent donc des conséquences multiples : erreurs médicamenteuses, perte d'information, allongement du temps de transmission, stress des professionnels, et in fine mise en danger du patient et des professionnels de santé. Pour ces mêmes faits, à mon niveau d'apprenant, les pourcentages seraient indéniablement plus élevés.

Face à ces constats, j'ai élaboré plusieurs outils pour structurer ma participation aux transmissions.

Structuration de l'écoute active, j'utilise maintenant mentalement la méthode SBAR pour organiser ce que j'entends, sans interrompre la transmission.

Lors d'interruption ; j'essaie de me concentrer sur la feuille de transmission et ne pas m'occuper de l'environnement, qui en tant qu'apprenant ne me concerne pas.

Je compare mon lexique et marque systématiquement d'un point d'interrogation tout sigle ou mot médical inconnu, sans interrompre le flux de transmission. Cela me permet de les rechercher ensuite ou de les valider avec l'IDE référente.

J'applique également le principe de la boucle fermée a posteriori : je reformule 2 à 3 points importants après la transmission avec l'infirmière référente, pour m'assurer d'avoir bien compris.

Lors de l'analyse de données transmises je surligne tout ce qui me semble impacter la réalisation d'exams scanner, IRM ou radiographie : statut d'isolement du patient, nécessité d'être à jeun, présence d'une voie veineuse périphérique, niveau de douleur ou présence de vomissements, modalités de transport.

Je simplifie ma fiche de transmission près chaque transmission pour ne garder que les éléments impactant ma pratique à mon niveau, supprime la masse d'information polluant ma compréhension, je repère les situations pertinentes pour mon apprentissage : pose de vvp, les procédures d'isolement (iso contact, iso protection, iso parasite), les actes de soins à voir : (réfection de pansement complexe ..)

Tout au long de la journée, je pratique ce qui relève de mes compétences d'étudiant, prise et analyse de constante, identitovigilance, questionnement et analyse de la douleur, mesure d'hygiène, bilan sanguin..., et je pose mes questions aux moments calmes, pour ne pas générer moi-même des interruptions de tâches supplémentaires. Je compare régulièrement la feuille de transmission avec mon lexique d'acronymes en construction, pour chaque patient si nécessaire.

Le plan de journée transforme l'impression diffuse « d'être perdu » en une liste concrète d'objectifs simplifiés, adaptée à mon statut d'étudiant. Je ne cherche plus à tout faire ou tout comprendre comme une infirmière diplômée, ce qui n'est ni réaliste ni souhaitable.

Ces stratégies bien qu'utiles ont des limites, elles demandent du temps supplémentaire pas toujours disponible en début de poste ainsi qu'une validation avec l'IDE, consultation du lexique, rédaction du plan de journée. Cependant, ce temps est largement compensé par l'efficacité accrue ensuite.

Certains sigles restent ambigus sans le contexte clinique complet. J'ai appris à accepter de noter sans comprendre immédiatement, pour ne pas perturber la transmission d'information, puis à valider plus tard avec l'IDE.

J'essaie consciemment de ne pas submerger l'infirmière en poste de questions incessantes. Je recherche au maximum par moi-même en amont, pour éviter de créer des interruptions de tâche supplémentaires de ma part.

Pour mes prochains stages, je prévois d'anticiper davantage le fonctionnement général de chaque unité de soins : type de pathologies prises en charge, actes techniques courants, organisation temporelle de la journée.

Je constituerai en amont un lexique de base en lien avec la spécialité du service, ainsi qu'un glossaire des acronymes classiques utilisés dans ce type d'unité à compléter uniquement des acronymes spécifiques internes.

Cette expérience en stage infirmier m'a fait prendre conscience de l'importance de maîtriser les acronymes usuels du secteur de santé. La méthode SBAR, associée à une check-list personnelle et à une validation systématique, reste pertinente pour mon futur métier de manipulateur en électroradiologie.

Un principe fondamental que j'ai intégré : je n'agis jamais sans prescription ou protocole écrit.

Comprendre ce qui perturbe une tâche et les conséquences me sera également utile : en imagerie, les échanges avec les services demandeurs doivent être clairs et structurés pour garantir la qualité et la sécurité des examens réalisés.

En conclusion, ma difficulté initiale n'était finalement pas tant d'ordre technique ou relationnel, mais relevait d'une préparation insuffisante pour comprendre et m'organiser dans un environnement professionnel nouveau. Les connaissances théoriques seules ne suffisent pas : il faut également développer des stratégies méthodologiques d'apprentissage.

En adoptant la méthode SBAR, un lexique validé progressivement et un plan de journée simplifié, je réduis considérablement la confusion ressentie et je reste dans un cadre de pratique sûr, à la fois pour les patients et pour mon propre apprentissage.

Je poursuis l'utilisation de ces outils jusqu'à ce que le jargon professionnel devienne progressivement familier. Cette première expérience m'a appris qu'être étudiant, ce n'est pas être incompetent, mais être en apprentissage structuré, avec des outils adaptés à cette phase de formation.

Bibliographie

- **Textes réglementaires**

France : Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif aux transmissions infirmières.

Europe (contraignant) : essentiellement lié à la charge mentale et risques :
Directive-cadre 89/391/CEE : obligation générale d'évaluer et prévenir *tous* les risques pour la santé et la sécurité

Directive 90/270/CEE "écrans de visualisation" : texte explicite sur la charge mentale.

- **Communication et transmissions**

Doyon, O. & Longpré, C. (2016 → 2^e éd. 2022). *Évaluation clinique d'une personne symptomatique* les thèmes « communication », « transmissions », SBAR/SCAR et collaboration interpro sont traités dans l'intro/méthodo et au chapitre « Douleur », « Signes vitaux », etc. [LIVRE librairie](#)

Hannawa, A. (2019). *La sécurité des patients*.

Haute Autorité de Santé. (2014). *Guide pour faciliter la communication entre professionnels de santé - Méthode SAED*. Paris : HAS. [site internet](#)

IFSI *Les transmissions infirmières : guide pratique*. [site internet](#)

- **Interruptions de tâche et sécurité des soins**

Haute Autorité de Santé. (2016). *Interruptions de tâche lors de l'administration des médicaments*. Disponible sur : [site internet](#)

Haute Autorité de Santé. (2022). *Journée mondiale de la sécurité des patients 2022 : Les médicaments sans les méfaits*. Paris : HAS.

Institut de Prévention Médicale. *Gestion des interruptions de tâches : principes généraux*. [Site internet](#)

Rapport national Suisse, FOPH *enhancing the quality and safety of swiss healthcare* [site internet](#)

Moll, M.-C. (2013). *La gestion des interruptions de tâches au CHU d'Angers : une approche des facteurs humains*. Journées Internationales de la Qualité Hospitalière en Santé (JIQHS).

Westbrook, J.I., Woods, A., Rob, M.I., Dunsmuir, W.T.M., & Day, R.O. (2010). *Association of Interruptions With an Increased Risk and Severity of Medication Administration Errors*. *Archives of Internal Medicine*, 170(8), 683-690

Centre hospitalier de Martigues : 2017-2018 erreur médicale suite interruption de tâche : *Prévenir les interruptions de tâches lors des soins : Un changement culturel complexe, un défi à relever* [site internet](#)

Haute école de santé de Fribourg : Risques liés aux interruptions de tâche en milieu hospitalier. *Relève infirmière : moyens de communication et sécurité des patients hospitalisés. Une revue de littérature.* [site internet](#)

bloomr-impulse *Le mythe du multitasking et les clés pour préserver sa concentration au travail* [site internet](#)

- **Risque lié à la santé des professionnels de santé**

Souffrance et travail *L'interruption de la tâche : la banalité du quotidien des soignants vue comme facteur de risque psychosocial* [site internet](#)

INRS :

1. *Dépister les risques psychosociaux (ED 6012)* — rubriques d'indicateurs :
« L'interruption de l'activité est un facteur de surcharge mentale et psychique largement reconnu. » [inrs.fr](#)
2. *Utiliser les outils numériques pour la communication" (05/09/2023)* :
« Les interruptions dans les activités deviennent beaucoup plus fréquentes. Il en résulte une charge mentale croissante qui favorise le développement du stress... » [inrs.fr](#)
3. *Risques psychosociaux — Ce qu'il faut retenir* (page de référence). [Inrs.fr](#)
4. *Travail et charge mentale* (références INRS : les interruptions font partie des facteurs de charge mentale). [portaildocumentaire.inrs.fr](#)

- **Organismes internationaux**

Organisation Mondiale de la Santé. (2017). *L'OMS inaugure une initiative mondiale pour réduire de moitié les erreurs médicamenteuses en 5 ans*. Défi mondial pour la sécurité des patients. Genève : OMS. Disponible sur : <https://www.who.int>

Organisation Mondiale de la Santé. (2022). *Journée mondiale de la sécurité des patients 2022 : Les médicaments sans les méfaits*. Genève : OMS.